

Запор

Информация для пациента · Почему это важно для здоровья тазового дна и как это исправить

WARWIKI

Запор — это **редкий, твёрдый или затруднённый стул**. Это очень распространённое состояние, и оно важно для здоровья тазового дна: **натуживание** усугубляет пролапс (опущение), недержание мочи и тазовую боль. Хорошая новость: в большинстве случаев запор устраняется простыми проверенными мерами.

Об этом состоянии

При здоровом кишечнике стул должен выходить без натуживания. Признаки запора: стул реже трёх раз в неделю, твёрдые или комковатые массы, натуживание, ощущение **неполного опорожнения**, необходимость надавливать на область влагалища или прямой кишки для дефекации («шинирование»).

Причины

- **Мало клетчатки и жидкости**, недостаточная физическая активность
- **Игнорирование позывов** к дефекации
- **Лекарства** — опиоиды, препараты железа, некоторые другие
- **Проблемы с тазовым дном** — мышцы не расслабляются для прохождения стула («выходной» запор)
- Замедленная моторика толстой кишки

«Выходной» запор важно распознать: он лечится **терапией тазового дна**, а не только слабительными.

ТЕРМИНЫ

Запор

Редкий, твёрдый или затруднённый стул.

Клетчатка

Растительные волокна, которые смягчают и увеличивают объём стула.

Осмотическое слабительное

Мягкое средство (например, PEG), притягивающее воду в кишечник.

Выходной запор

Затруднение дефекации из-за нерасслабления мышц тазового дна.

Биофидбэк

Терапия, обучающая мышцы расслабляться при дефекации.

Шинирование

Надавливание у влагалища или прямой кишки для облегчения стула.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ДЛЯ УРОЛОГА? Натуживание при твёрдом стуле давит на те же структуры поддержки, которые удерживают мочевой пузырь и тазовые органы — поэтому запор усугубляет пролапс и недержание мочи, а переполненная прямая кишка сдавливает мочевой пузырь. Устранение запора нередко улучшает и симптомы со стороны мочевого пузыря.

Как это лечат (шаг за шагом)

- 1 Клетчатка, жидкость и активность** — увеличивайте клетчатку постепенно (из пищи или в виде добавки), запивая достаточным количеством воды.
- 2 Режим дефекации** — ходите при позыве, используйте **подставку для ног** (поза на корточках) и **не натуживайтесь**.
- 3 Мягкие слабительные** — осмотическое средство (например, PEG) безопасно при регулярном применении.
- 4 Терапия тазового дна / биофидбэк** при выходном запоре; обсудите с врачом все лекарства, вызывающие запор.

Здоровый режим

- Старайтесь ходить в туалет **в одно время каждый день**, часто после еды.
- Дайте себе время без спешки; никогда не форсируйте и не натуживайтесь.
- Будьте активны — даже ежедневная прогулка стимулирует работу кишечника.

Полезно знать

- Добавляйте клетчатку **постепенно**, чтобы избежать вздутия, и пейте достаточно воды.
- Стимулирующие слабительные допустимы изредка; перед регулярным применением проконсультируйтесь с врачом.
- Если главная проблема — натуживание, вероятно, дело в координации мышц: терапия поможет больше, чем увеличение дозы слабительных.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Кровь в стуле** или необъяснимая потеря веса
- Новый запор, не поддающийся лечению, особенно в старшем возрасте
- Сильная боль в животе, рвота или **отсутствие газов и стула** (возможная непроходимость)

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

- Запор распространён и важен для здоровья тазового дна: натуживание усугубляет пролапс и недержание мочи.
- Лечите его клетчаткой, жидкостью, активностью, правильными привычками (подставка для ног, без натуживания) и при необходимости мягкими слабительными.
- При сохраняющемся натуживании спросите о терапии тазового дна. Сообщайте врачу о крови в стуле, потере веса или резком изменении стула.